Prendre en charge un traumatisme

Traiter toute détresse vitale avant le traumatisme

Conseiller de ne pas bouger

Bassin

Contrôle bassin (dénuder)

Détresse circulatoire

consigne du médecin
ou avis médical impossible à avoir

Ceinture pelvienne

non

Membres inférieurs et supérieurs

Inférieur
Position allongée

Supérieur
Position assise

Fracture

fermée

ouverte

non

Avis médical

consigne du médecin
ou impossible à avoir

Réalignement

Application froid

Déformation

oui

non

Attelle dépression

Attelle modulable
Echarpes

Poursuivre l'intervention

Dos / Cou / Crâne

Victime agitée non coopérative (oui)

non

Si besoin stabiliser rachis

Fiabilité des réponses (A) de la victime ? (non)

oui

Signes d'atteinte du rachis (B) ou de la moelle (C) ? (oui)

non

Traumatisme à haut risque d'atteinte du rachis (D) ? (non)

oui

Âge > 65 ans ou antécédents à risque (E) ? (oui / non)

Stabilisation	Restriction	Immobilisation
Demander de ne pas bouger Maintien tête	Blocs de tête Collier cervical MID	MID Plan dur (si MID indispo) Combinaison de moyens

Pas d'immobilisation du rachis

La victime se déplace seule

Aggravation (oui)

Installation dans un vecteur

Immobilisation du rachis

Accès difficile
Plan dur
Attelle Cervico Thoracique

Victime au sol
Cuillère
Plan dur
Relevage à 4

Immobilisation MID

Poursuivre l'intervention